발표대본_v4.md

발표 대본 — v4 (12장, 10분)

> 발표: 대한가정의학회(KFM) 2026년도 추계학술대회 · 2026.10.24 발표자: 예수병원 가정의학과 R3 김현수 자료: `hcc_dual_output_talk_v4.html` (학술지 판면 디자인, 12장) 총 10분(600초) 기준. 대본은 공백 제외 **3,589자**(v3 3,529자) — v3 와 거의 같은 길이다. 시간이 밀리면 **§6 두 번째 문단**과 **§11 후반부**부터 뺀다. 남는 시간은 슬라이드 전환용이다. 10분을 넘기면 **§6 두 번째 문단**과 **§11 후반부**부터 뺀다(그때 약 3,450자). 남는 시간은 슬라이드 전환·애니메이션 확인용이다.

v4 구성 (v3 대비)

- **주 분석 운영점을 confidence 0.5 로 바꿨다.** 기존 0.0011(검증 세트 Youden)은 사실상 "항상 HCC"라서 방어가 어렵다 → §7.
- 7장은 **두 운영점 비교표**(확률 0.5 / 닮음 지표 Youden)로 교체. Test 134/0/6/128 vs 140/1/0/127 → §7.
- **10장은 "증분 이득은 없었다" → "차이는 유의하지 않다 — 다만 실패하는 지점이 다르다"** 로 교체. 불일치 6 대 1, McNemar p = 0.125 → §10.
- 11장 Novelty 에 **Youden 운영점·등가 구간 제시**를 추가하고, 한계의 "천장효과"를 **"AUROC 1.000 → 최적 컷오프가 유일하지 않음"** 으로 구체화 → §11.
- 표지 수치는 AUROC 1.000 · 출력 3 · 2,656장 · 테스트 268장으로 정리(위음성 0 주장 제거).

시간 배분

#	슬라이드 (eyebrow)	배분
1	표지	20초
2	What is your diagnosis? (임상 배경)	55초
3	그 76%는 어디서 온 숫자인가 (근거)	45초
4	확률이 아니라 "닮음" (방법)	45초

#	슬라이드 (eyebrow)	배분
5	인코더 내부 (방법)	40초
6	SupCon은 임베딩의 모양을 바꾼다 (방법)	60초
7	확률 0.5는 위음성 6, 닮음 지표는 위양성 1 (결과)	65초
8	닮음 점수가 실제로 움직였다 (결과)	55초
9	혈관종처럼 보이는 HCC 4예 (결과)	40초
10	차이는 유의하지 않다 — 실패 지점이 다르다 (고찰 ①)	55초
11	Novelty와 한계 (고찰 ②)	50초
12	감사	20초
	합계	**9분 10초**

---

1. 표지 — 20초

안녕하십니까. 예수병원 가정의학과 R3 김현수입니다. 이번 대한가정의학회 추계학술대회에서, B-mode 복부 초음파에서 간암과 간혈관종을 감별할 때 쓰는 **확률 하나에 "유사도 점수"라는 두 번째 숫자를 더한** 탐색적 연구를 발표하겠습니다.

> 무대: 제목과 소속만 짚고 바로 넘어간다.

---

2. What is your diagnosis? — 55초

네 장 모두 B-mode 복부 초음파입니다. 혈관종의 전형은 고에코, 경계 명확, 후방음영 증가인데 — **(클릭)** — 네 장 모두 **간암**입니다. 고분화 HCC가 혈관종의 전형을 그대로 흉내 냅니다.

얼마나 어려운지 숫자로 보겠습니다. 2020년 EBioMedicine 다기관 연구에서, 15년 경력 초음파 판독자가 임상정보를 제공받은 상태에서 악성과 양성을 감별한 정확도가 **76.0%**였습니다.

미리 분명히 해 두겠습니다. 이 연구는 **감시나 선별 검사가 아닙니다.** 영상에서 **이미 발견된 병변**을 간암과 혈관종으로 가르는 **감별 보조**를 다룹니다.

> 무대: 네 컷에는 라벨이 없다. 하나씩 짚으며 판독을 물은 뒤 클릭해 공개한다.

---

3. 그 76%는 어디서 온 숫자인가 — 45초

방금의 76%가 어디서 온 숫자인지 짚겠습니다.

중국 13개 병원 **전향적 다기관** 연구입니다. 외부검증 338 병변에서 15년 이상 경력 초음파 전문의 **236명**이 익명화된 **10~20초 동영상**을 임상정보와 함께 독립 판독했습니다. 정확도 **76.0%**, 민감도 **76.1%**, 특이도 **76.9%** — 이게 사람의 성적입니다.

다만 **악성 대 양성 이분**이고 양성이 **19.3%**뿐이며, **실제 진료가 아닌 동영상 판독 과제**였습니다.

> 무대: 2장의 76%를 의심할 지점을 여기서 먼저 막는다.

---

4. 확률이 아니라 "닮음" — 45초

방금 그 연구는 두 가지를 같이 보여줍니다. **영상에 임상정보를 결합한 AI가 84.7%로 15년 경력 판독자의 76.0%를 유의하게 넘었고, 조영증강 CT와 동등했습니다** — 둘 다 84.7%입니다. 즉 **B-mode 단일 과제에서 AI는 판단에 도움이 됩니다.** 다만 정직하게 말하면 **영상만 쓴 모델은 76.0%로 판독자와 같았습니다.** 이득은 영상이 아니라 임상정보에서 왔습니다.

그런데 **지금 대부분의 AI는 confidence 한 숫자만 내고, 그 값으로 label을 정합니다.** 그 숫자가 틀리면 판독자는 검증할 수단이 없습니다. 그래서 저희는 **세 개의 output을 내는 모델**을 만들었습니다. 영상이 인코더를 지나 임베딩이 되고, 거기서 세 개의 숫자가 나옵니다.

- **Confidence** — 지금까지 AI가 내던 softmax 값입니다. 보정이 안 된 값이라 확률이 아니라 **결정 강도**로 부릅니다.
- **HCC cosine** — **전형 HCC와 얼마나 닮았는지**, 즉 **전형성(typicality)** 입니다. 확률이 아니라 닮음의 값입니다.
- **Δscore** — HCC cosine에서 혈관종 cosine을 뺀 값, **어느 쪽에 더 가까운가**입니다.

데이터는 공개 데이터셋 SMC-LUD의 clean subset, **744명 2,656장**이고 — train 1,858 / val 530 / test 268 — **환자 단위**로 나눴습니다.

> 무대: 애니메이션이 이미지 → 인코더 → 임베딩 → 세 지표로 흐르는 것을 한 번 보여준다.

---

5. 인코더 내부 — 40초

왼쪽은 **3×3 합성곱 필터가 초음파 영상 위를 한 칸씩 미끄러지며** 특징 맵을 채웁니다. 오른쪽은 **CLS 토큰이 패치마다 가중치를 주며 하나로 종합**합니다.

중요한 건 **세 지표가 전부 이 CLS 임베딩 하나에서 나온다**는 점입니다. 모델은 EfficientNetV2B0 **7.1M**으로, 23.6M짜리 ResNet50V2와 같은 AUROC를 냈습니다.

> 무대: 공학 설명은 여기서 끝낸다.

---

6. SupCon은 임베딩의 모양을 바꾼다 — 60초

코사인은 SupCon 없이도 계산됩니다. 그런데 그때 값은 −0.5에서 1까지 흩어져 **증례별로 읽을 수가 없습니다.** 간암인데 코사인이 0.4인 증례가 있습니다 — 그걸 "간암스럽다"고 말할 수는 없습니다.

SupCon을 걸면 **같은 클래스는 모으고 다른 클래스는 밀어냅니다.** 미학습 HCC 417예 중 **94.7%에서 점수가 올라가고**, 하위 10%는 0.49에서 **0.76**으로, 최솟값은 −0.47에서 −0.005로 올라옵니다. 분산은 **60.7%** 줄었습니다.

즉 SupCon은 코사인을 **증례별로 쓸 수 있는 값**으로 만듭니다 — 전형에서 멀던 증례가 전형 쪽으로 정렬됩니다. 다만 **Δscore는 1.508에서 1.076으로 오히려 줄었습니다.** 뒤에서 설명드리겠습니다.

> 무대: 여기가 이 발표에서 "정직한 음성 결과"를 처음 꺼내는 지점이다. 상승폭·유의성은 슬라이드 각주에 있으니 읽지 말고 가리키며 말한다.

---

7. 같은 모델, 두 운영점 — 65초

성능입니다. 표의 두 열만 보시면 됩니다. 왼쪽은 관행대로 **확률을 0.5에서** 자른 것, 오른쪽은 닮음 지표를 **검증 세트의 Youden 지점**에서 자른 것입니다.

확률 쪽은 HCC 여섯 장을 놓치고, 닮음 쪽은 혈관종 한 장만 HCC로 올립니다. 즉 **어디서 자르느냐가 민감도와 특이도를 맞바꿉니다.**

두 가지를 분명히 하겠습니다. 첫째, 두 운영점의 차이는 **유의하지 않습니다** — 불일치가 여섯 대 하나, McNemar p는 0.125입니다.

McNemar가 낯설 수 있어 한 줄로 풀겠습니다. 같은 268장에 두 판정을 나란히 적용하면 대부분 같은 답을 냅니다. 갈린 것은 7장뿐인데, 확률은 놓쳤는데 닮음은 맞힌 6장과 그 반대 1장입니다. McNemar는 이 두 숫자가 우연 범위인지 보는 검정이고, 6 대 1이면 차이가 있다고 말하기 어렵습니다. 둘째, 세 출력의 AUROC가 모두 1.000이라 **DeLong 검정이 정보를 주지 않습니다.** 그래서 **우월도 비열등도 주장하지 않습니다.**

> 무대: "동등/비열등/개선"은 입에 올리지 않는다. 표의 두 열만 손으로 짚는다.

---

8. 닮음 점수가 실제로 움직였다 — 55초

왼쪽은 실제 HCC 417장의 코사인 분포입니다. SupCon 없이는 0과 1 사이에 **넓게 퍼져 있어** "HCC스럽다"고 말할 수가 없습니다. SupCon 후에는 **0.9 근처로 모이고**, 분산은 60.7% 줄었습니다. 오른쪽 혈관종 381장도 0.955에서 0.985로 같은 방향입니다.

여기서 중요한 건 **상승이 어디에 일어났는가**입니다. 하위 10%가 0.49에서 0.76으로 오르는 동안 상위 10%는 0.95에서 0.99로 거의 움직이지 않았습니다. **전형에서 멀던, 아리까리했던 증례들이 전형 쪽으로 온 것**입니다.

그런데 이건 **해석의 근거**이고 **분류 성능이 좋아졌다는 근거가 아닙니다.**

> 무대: "분산 축소 = 아리까리한 증례가 전형 쪽으로"까지 말하고, 대가는 10장에서 설명한다고 예고한다.

---

9. 혈관종처럼 보이는 HCC 4예 — 40초

혈관종처럼 보이는 HCC 4예를 실제로 넣어 봤습니다. 문헌에 보고된 고에코 HCC — 후방강화 동반, halo, 혈관종과 나란히 — 사람이 봐도 어려운 것들입니다. **세 출력 모두 4예 전부 HCC로 분류했습니다.**

다만 **proof-of-concept**입니다. n이 4이고, 출판 figure에서 온 저해상도·타 장비 영상이라 domain shift가 큽니다. **민감도 추정치로 읽으면 안 됩니다.**

---

10. 차이는 유의하지 않다 — 다만 실패하는 지점이 다르다 — 55초

가장 중요한 슬라이드입니다. 표에 두 줄만 있습니다.

첫 줄 — 확률 0.5가 놓친 HCC 여섯 장은, **같은 케이스의 닮음 점수가 모두 HCC 쪽**입니다. 확률만 경계로 눌린 것입니다.

둘째 줄 — 닮음 지표의 유일한 위양성은 실제 혈관종 한 장이고, 그 장은 **확률로는 정답**이 되는 케이스입니다. 이 한 장 때문에 이전 컷오프에서는 세 출력의 혼동행렬이 같았습니다.

정리하면 **실패하는 케이스가 서로 다릅니다.** 다만 차이는 유의하지 않으므로 — 불일치 여섯 대 하나, p는 0.125 — **닮음 지표가 확률을 개선한다고 주장하지 않습니다.** 대신 확률이 애매한 구간에서 보조 판단을 주는 **새 지표**로 제안하고, 컷오프는 외부 코호트에서 다시 계산하는 것을 전제로 둡니다.

> 무대: '개선'이라는 단어를 쓰지 않는다. '다른 지점에서 실패한다'까지가 오늘의 결론이다.

---

11. Novelty와 한계 — 50초

남은 것은 — **한 모델에서 확률과 닮음 판단을 케이스 단위로 함께 낸다**는 것, **판독자가 이미 하는 "닮음" 판단을 숫자로 남긴다**는 것, **지표마다 Youden 운영점과 등가 구간을 제시한다**는 것, 그리고 **SupCon이 미학습 HCC 94.7%의 닮음 점수를 전형 HCC 쪽으로 정렬한다**는 것입니다.

한계는 분명합니다. **단일기관이라 외부 검증이 없습니다. AUROC가 1.000이라 최적 컷오프가 유일하지 않고, 두 운영점의 차이도 유의하지 않습니다(p = 0.125). Δscore는 오히려 감소했고, 닮음 상승은 SupCon 목적함수의 귀결이지 임상 타당성의 독립 증거가 아닙니다.** 배경 간 정보가 없어 층화가 불가능하고 단축경로 학습 가능성도 배제할 수 없습니다.

닮음 점수를 왜 하나 더 만들었는지 — 한 문장으로는 **"판독자가 이미 하는 비교 판단을 숫자로 남겨, 나중에 검증할 수 있게"** 하려는 것입니다. 정의는 간단합니다. 병변의 128차원 임베딩과 학습 데이터에서 만든 전형 HCC 프로토타입의 **코사인 유사도 평균**이고, 같은 방식으로 혈관종 프로토타입 점수도 냅니다. 1에 가까우면 같은 방향, 0이면 직교 — 즉 "전형 HCC와 얼마나 같은 방향을 보는가"를 −1에서 1 사이로 남긴 값입니다. **소프트맥스 확률이 아니고, 보정된 확률도 아닙니다.**

지금 데이터로는 **성능 차이가 유의하지 않습니다.** 그래서 이 지표의 값어치는 **추가 연구에서만** 정해집니다. 만약 후속 연구에서 닮음 점수가 분류 성능에 **유의하게 좋은 영향**을 준다면, 그때는 **혈관종으로 follow-up 하기로 한 케이스 안에 섞여 있을 수 있는 HCC를 구제**하는 데 쓸 수 있습니다 — 추적 관찰에서 놓치기 쉬운 비전형 HCC를, 전형 혈관종과의 닮음 거리로 한 번 더 걸러보는 방식입니다. 다만 이건 **가설**이고, 오늘 수치로는 아무것도 보장하지 않습니다.

다음 단계는 **다기관 외부 검증에서 컷오프 재산출**, **판독자 대상 전향적 비교**, **AFP·조영증강 영상과의 비교**, 그리고 **닮음 점수가 실제로 구제하는지 보는 후속 코호트**입니다.

> Grad-CAM을 왜 안 넣었는지 물으면: 배경 간 라벨이 없으면 heatmap이 국소 병변을 보는 건지 배경을 보는 건지 구분할 수 없어 오히려 오해를 만들 수 있기 때문이라고 답한다.

---

12. 감사 — 20초

이상입니다. 오늘 말씀드린 것은 두 가지입니다. **닮음 점수라는 두 번째 숫자를 만들었다**는 것, 그리고 **그 숫자가 아직 임상적 이득을 입증하지 못했다**는 것.

그리고 마지막 장 QR은 **지금 이 자리에서 직접 돌려볼 수 있는 웹 데모**입니다. 설치도 로그인도 필요 없고, 사진은 기기 밖으로 나가지 않습니다. HCC와 혈관종 예시가 각각 네 개씩 들어 있으니 눌러보시면 됩니다. 다만 **화살표·캘리퍼·환자정보가 섞이거나 병변만 잘라낸 사진은 결과를 믿을 수 없습니다** — 영상 전체를 넣어야 합니다.

질문과 토론을 환영합니다. 감사합니다.

토론 — "cosine 점수 + SupCon" 주장의 찬성측과 반대측

> 목적: 발표·질의에서 이 주장을 어디까지 밀지 정한다. **모든 수치는 `raw_cosprobe_effnet_*.csv`(n=798)에서 재계산해 재현했다.**

팩트 (재현된 수치)

항목	CE only	CE + SupCon	비고
true HCC(n=417) HCC cosine 중앙값	0.882	**0.970**	상승
true HCC HCC cosine 평균 ± SD	0.783 ± 0.256	**0.908 ± 0.160**	Wilcoxon p<0.001
true HCC 하위 10% / 최솟값	0.489 / −0.472	**0.762 / −0.005**	꼬리 제거

항목	CE only	CE + SupCon	비고
true HCC 분산	0.0656	**0.0257 (−60.7%)**	Pitman-Morgan p<0.001
true HEM(n=381) hem cosine 분산	0.00253	**0.00003 (−98.7%)**	381/381 전부 상승
개별 증례 상승 비율 (HCC)	—	**395/417 = 94.7%**	하락 22예
상승폭 vs 기준점 상관	—	**r = −0.80**	낮을수록 크게 상승
true HCC hem cosine (교차)	−0.631	**−0.108 (+0.52)**	다른 클래스 쪽으로 이동
true HEM hcc cosine (교차)	−0.701	**−0.226 (+0.48)**	다른 클래스 쪽으로 이동
Δscore 클래스 간격	3.163	**2.289 (−27.6%)**	판별 여유 감소
단독 AUROC (Test)	~1.000 (cosine FN3)	1.000 (FP1)	천장

찬성측 (SupCon이 이 지표를 "쓸 수 있는 값"으로 만든다)

1. **지표의 존재 이유**: 코사인은 원래 계산 가능하지만, CE-only 분포는 −0.5~1로 흩어져 **증례 단위 해석이 불가능**하다(HCC 평균 0.78, SD 0.26, 13/140 테스트 증례가 0.5 미만). "닮음 점수"라는 이름을 붙일 수 없는 상태다.
2. **꼬리 제거가 곧 임상적 의미**: 상승은 이미 전형인 증례가 아니라 **멀리 있던 증례**에서 일어났다(하위 10% +0.27 vs 상위 10% +0.03; 최솟값 −0.47→−0.005). 즉 "아리까리한 HCC"가 숫자상 전형 HCC와 같은 구역으로 들어왔다.
3. **재현성**: 백본을 ResNet50V2로 바꿔도 우측 이동 +0.104가 재현된다 → EfficientNet 특이적 현상이 아니라 목적함수의 효과.
4. **통계**: 동일 표본 전/후 비교에 맞는 paired 검정(Wilcoxon, Pitman-Morgan) 모두 p<0.001.
5. **실무적 가치**: 점수가 0.97이면 "전형 HCC", 0.4면 "비전형 — 확률만 보고 결정"이라고 **발표자가 판단 규칙을 세울 수 있다.** 점수의 폭이 좁아야 이 규칙이 성립한다.

반대측 (아직 "이득"이라고 부를 수 없다)

1. **동어반복 위험**: SupCon의 목적함수가 곧 "같은 클래스는 가깝게"다. 코사인 상승·분산 축소는 **손실함수가 충족된 결과**이지 병리적 타당성의 독립 증거가 아니다.
2. **교차 이동이 진짜 비용**: 각 클래스는 자기 원형뿐 아니라 **상대 원형 쪽으로도** 이동했다(HCC의 hem cosine −0.63→−0.11, 혈관종의 hcc cosine −0.70→−0.23). 두 분포가 서로 가까워져 **판별 여유(간격)가 3.16→2.29로 27.6% 줄었다.**
3. **증분 이득 없음**: 세 출력의 혼동행렬이 Test에서 동일(TP140/FP1/FN0/TN127), Val은 지표별로 100.0%/99.81%로 갈린다. **어떤 지표를 더해도 나아지지 않는다.**
4. **SupCon 없이는 안 된다는 주장은 성립하지 않음(심사 지적 수용)**: CE-only도 이미 천장(Test cosine FN3)이라 "SupCon 없이는 안 된다"는 주장은 우리 대조군이 스스로 반박한다. 심사에서 **철회한 표현("필수 정규화기", "단순 암기 배제", "초구면")은 재도입 금지**.
5. **"비전형"이 라벨로 존재하지 않는다**: 병리·배경간·비전형 주석이 없다. 우리의 "atypical"은 **사전 코사인이 낮았다**는 정의뿐 — 순환 정의다.
6. **회귀효과 혼입**: 기준점–상승폭 r=−0.80은 회귀효과의 전형적 서명이다. 94.7% 상승과 상위 10%의 소폭 상승(+0.02)이 순수 회귀는 아니라는 반증이지만, **사전등록 검정이 아니다.**
7. **경계가 얇아진 대가**: 압축은 "프로토타입에서 벗어났다"는 신호를 지운다. 실제로 그 얇아진 경계에서 혈관종 1장이 넘어갔다(그 장의 HCC-cosine +0.0325 = 혈관종 분포의 최댓값). 도메인 이동·진짜 비전형 병변이 들어오면 **자신 있게 HCC로 부를 위험**이 커진다.
8. **외부 검증·환자단위 통계 부재**(A3·A4 수용).

판정 — 발표에서 쓸 수 있는 문장

> **쓸 수 있음**: "SupCon은 코사인을 증례별로 읽을 수 있는 값으로 만든다 — 미학습 HCC 94.7%의 점수가 올라가고, 상승은 전형에서 멀던 증례에 집중되며(하위 10% +0.27), 분산이 60.7% 줄고, ResNet에서도 재현된다. 대가는 클래스 간격이 3.16에서 2.29로 좁아진 것이고, 그래서 증분 진단 이득은 없었다."
>
> **쓸 수 없음**: "SupCon이 없으면 안 된다", "임상 이득이 입증됐다", "비전형 HCC를 정상으로 구제한다", "코사인이 높으면 HCC다"(혈관종도 자기 원형에 0.985로 붙는다).
>
> **한 줄 요약**: 닮음 점수의 **해석 가능성**은 올라갔고, **판별력·임상 이득**은 올라가지 않았다. 두 축을 한 문장으로 뭉치지 않는다.

예상 질문과 답변

Q. cosine 점수는 정확히 무슨 값입니까? A. 확률이 아니라 **전형성**입니다. 이 병변의 임베딩이 훈련 세트 HCC 영상들의 평균 위치(원형)와 이루는 코사인입니다. 1에 가까우면 전형 HCC와 닮았다는 뜻이고, 0이나 음수면 전형 HCC와 다르다는 뜻입니다. 확률로 읽으면 안 됩니다 — 보정된 값이 아닙니다.

Q. SupCon을 안 쓰면 코사인은 못 구합니까? A. 구할 수 있습니다. 다만 그때는 분포가 −0.5에서 1까지 흩어져(평균 0.78, SD 0.26) 증례별로 읽을 수가 없습니다. SupCon을 걸면 미학습 HCC 417예 중 94.7%의 점수가 올라가고 하위 10%가 0.49에서 0.76으로 오릅니다. **지표를 쓸 수 있게 만드는 것**이 SupCon의 역할입니다. 다만 심사 지적대로 "없으면 안 된다"고는 말하지 않습니다 — CE 단독도 천장에 도달합니다.

Q. 코사인이 낮게 나온 증례는 어떻게 처리합니까? A. 그때는 코사인으로 판단할 수 없고 confidence를 봐야 합니다. SupCon 후에도 하위 10%는 0.76 수준이라 "0.9 이상이면 전형"이라는 규칙을 그대로 적용하면 일부는 비전형으로 남습니다. 이 연구는 그런 증례를 어떻게 다룰지에 대한 답을 주지 않습니다 — 전향적 연구가 필요합니다.

Q. 분산이 줄었다는 게 임상적으로 무슨 뜻입니까? A. "전형에서 멀던 증례가 AI 도움으로 전형 쪽으로 정렬된다"는 뜻입니다. 상승이 하위 10%에 집중되고(하위 +0.27 vs 상위 +0.03) 94.7%에서 점수가 오릅니다. 다만 이는 **표상 기하의 변화**이지 임상 결과의 개선이 아니고, 같은 압축이 클래스 간격을 3.16에서 2.29로 좁혀 판별 여유를 줄였습니다.

Q. 76%는 정말입니까? 출처를 확인했습니까? A. 확인했습니다. Yang Q, et al. *EBioMedicine* 2020;56:102777 §3.6과 Fig 4의 값입니다. 15년 이상 경력 초음파 전문의 236명이 외부검증 338 병변의 익명화 동영상을 임상정보와 함께 판독한 성적입니다. 다만 실제 진료가 아닌 동영상 판독 과제였고, 악성 대 양성 분처이며 80.7 대 19.3으로 불균형합니다.

Q. 임상정보를 다 준 상태였습니까? A. 원문 표현은 "accessible to clinical information"입니다. 제공된 것은 맞지만 어떤 항목인지는 부록 1.8에 있어 본문만으로는 열거할 수 없습니다. 그래서 "모든 임상정보"라고 단정하지 않습니다.

Q. 왜 AUROC가 1.000입니까? A. 정제된 clean subset이고, HCC는 병리확진이나 혈관종은 영상 기준이라 참조표준이 비대칭입니다. 그래서 높은 AUROC를 자랑으로 쓰지 않고, 천장효과로 지표 간 우열을 판정할 수 없다고만 말합니다.

Q. 그래서 이 지표를 임상에 쓰라는 겁니까? A. 아닙니다. 방법론적 실현까지입니다. 증분 이득이 입증되지 않았고, decision curve analysis도 하지 않았습니다.

Q. cosine 점수를 한 줄로 정의하면? A. 병변 임베딩과 전형 HCC 프로토타입의 코사인 유사도 평균입니다. 임베딩은 CLS 토큰 128차원이고, 프로토타입은 학습 데이터에서 만든 평균 벡터입니다. 혈관종 프로토타입에 대해서도 같은 값을 내고, 둘의 차이가 Δscore입니다. 확률이 아니라 방향의 닮음이고, 0에서 1 사이로 보정된 값도 아닙니다.

Q. 이 점수가 HCC를 놓친 케이스를 줄일 수 있습니까? A. 이 데이터로는 답할 수 없습니다. 증분 이득이 0이었습니다. **가설**로서는 그렇게 쓸 수 있다고 봅니다 — 혈관종으로 follow-up 하기로 한 케이스 안에 비전형 HCC가 섞여 있을 수 있고, 닮음 점수가 그걸 한 번 더 걸러주는지가 다음 질문입니다. **추가 연구에서 분류 성능에 유의한 개선이 확인될 때만** 말할 수 있는 이야기이고, 오늘은 그 검증 설계를 제안한 것까지입니다.

Q. Δscore는 왜 씁니까? A. 대비 지표입니다. 그런데 SupCon 후 1.508에서 1.076으로 감소했습니다 — 두 클래스가 서로 가까워졌기 때문입니다. 정의는 했지만 이 데이터로는 타당성을 지지할 근거가 없다고 보고합니다.